FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

Bases e Métodos de Avaliação I • Fisioterapia – 2º termo

Acadêmico(a): _____ **RA:** _____

Docente: _____ **Data:** _____

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome: _____

Data de nascimento: _____ **Idade:** _____ anos **Telefone:** _____

Gênero: ☐ Feminino ☐ Masculino **Dominância:** ☐ Destro ☐ Canhoto

Estado civil: ☐ Solteiro(a) ☐ Casado(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Viúvo(a)

Profissão: _____ **Escolaridade:** _____

Endereço: _____

Diagnóstico clínico (médico): _____

Encaminhado por: _____ **Data:** _____

2. ANAMNESE

Queixa principal (QP) *o que mais incomoda, nas palavras do paciente (entre aspas ou SIC)*

História da doença atual (HDA) *quando e como começou, como evoluiu, o que melhora e o que piora*

História pregressa (HDP):

☐ Hipertensão ☐ Diabetes ☐ Cardiopatia ☐ Doença respiratória ☐ Outras:

Histórico familiar (HF): _____

Tabagista: ☐ Não ☐ Sim ☐ Ex **Etilista:** ☐ Não ☐ Sim ☐ Social

Atividade física: ☐ Não ☐ Sim Qual / frequência: _____

Medicamentos em uso: _____

Cirurgias / implantes: ☐ Nenhum ☐ Osteossíntese ☐ Prótese ☐ Marca-passo ☐ Outro

Exames complementares: _____

Nas atividades do dia a dia (AVDs), o paciente é:

☐ Independente ☐ Independente com dificuldade ☐ Parcialmente dependente
☐ Dependente

Atividades prejudicadas: _____

Expectativa do paciente com o tratamento: _____

3. SINAIS VITAIS

Sinal vital	Valor	Referência (adulto)	Classificação
Pressão arterial (PA)	____/____ mmHg	< 120/80	☐ Hipotensão ☐ Normal ☐ Pré-HA ☐ HA
Frequência cardíaca (FC)	_____ bpm	60 a 100	☐ Bradicardia ☐ Normocardia ☐ Taquicardia
Frequência respiratória (FR)	_____ rpm	12 a 20	☐ Bradipneia ☐ Eupneia ☐ Taquipneia
Temperatura (T°)	_____ °C	36 a 37,5	☐ Hipotermia ☐ Normal ☐ Febre

PA aferida no: ☐ MSD ☐ MSE **Posição:** ☐ Sentado ☐ Deitado

Ritmo cardíaco: ☐ Regular ☐ Irregular **Respiração:** ☐ Torácica ☐ Abdominal ☐ Mista

4. EXAME FÍSICO GERAL

Estado geral: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Chegou: ☐ Andando ☐ Com auxílio (bengala, muleta, andador) ☐ Cadeira de rodas

Pele: ☐ Normocorada ☐ Palidez ☐ Cianose ☐ Hiperemia ☐ Icterícia

Fácies: ☐ Atípica ☐ Dor ☐ Ansiedade ☐ Tristeza ☐ Outra:

Edema, cicatrizes ou outras alterações: _____

Palpação *temperatura local, pontos dolorosos, tensão muscular*

5. AVALIAÇÃO VASCULAR

Pulsos arteriais

Artéria	Direito	Esquerdo
Carótida	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Braquial	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Radial	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Femoral	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Poplítea	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Tibial anterior	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Tibial posterior	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente
Pediosa	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Ausente

Tempo de enchimento capilar (TEC)

Local	Direito	Esquerdo	Resultado
Mãos (leito ungueal)	_____ s	_____ s	☐ Normal (< 3 s) ☐ Alterado
Pés (leito ungueal)	_____ s	_____ s	☐ Normal (< 3 s) ☐ Alterado

6. AUSCULTA PULMONAR E CARDÍACA

Ausculta pulmonar

Murmúrio vesicular (MV): ☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Abolido

Ruídos adventícios: ☐ Ausentes ☐ Sibilos ☐ Roncos ☐ Estertores crepitantes ☐ Estridor

Local da alteração: ☐ Ápice D ☐ Ápice E ☐ Base D ☐ Base E ☐ Ambos hemitórax ☐ Global

Registro (ex.: “MV+ sem RA”): _____

Ausculta cardíaca

Bulhas: ☐ Normofonéticas ☐ Hiperfonéticas ☐ Hipofonéticas

Ritmo: ☐ Regular ☐ Irregular **Tempos:** ☐ 2 tempos ☐ 3 tempos (B3 / B4)

Sopros: ☐ Ausentes ☐ Presentes **Foco:** ☐ Aórtico ☐ Pulmonar ☐ Tricúspide ☐ Mitral

Registro (ex.: “BRNF 2T SS” = normal): _____

7. AVALIAÇÃO POSTURAL

Dor na coluna: ☐ Não ☐ Cervicalgia ☐ Dorsalgia ☐ Lombalgia

Fio de prumo – vista lateral: ☐ Alinhado ☐ Desalinhado Onde: _____

Fio de prumo – vista posterior: ☐ Alinhado ☐ Desalinhado Onde: _____

Segmento	O que foi observado
VISTA ANTERIOR	
Cabeça	☐ Simétrica ☐ Inclinada ☐ Rodada Lado: _____
Ombros	☐ Simétricos ☐ Assimétricos _____ mais baixo
EIAS	☐ Simétricas ☐ Assimétricas _____ mais baixa
Joelhos	☐ Simétricos ☐ Valgo ☐ Varo
Pés	☐ Simétricos ☐ Plano ☐ Cavo
VISTA LATERAL	
Cabeça	☐ Simétrica ☐ Anteriorizada ☐ Posteriorizada
Ombros	☐ Simétricos ☐ Protusão ☐ Retração
Coluna cervical	☐ Simétrica ☐ Hiperlordose ☐ Retificação
Coluna torácica	☐ Simétrica ☐ Hipercifose ☐ Retificação
Coluna lombar	☐ Simétrica ☐ Hiperlordose ☐ Retificação
Pelve	☐ Simétrica ☐ Anteroversão ☐ Retroversão
Joelhos	☐ Simétricos ☐ Recurvado
VISTA POSTERIOR	
Escápulas	☐ Simétricas ☐ Assimétricas ☐ Alada
Escoliose	☐ Ausente ☐ Em C ☐ Em S Região: _____
Giba	☐ Não ☐ Sim Lado: _____
Triângulo de Tales	☐ Simétrico ☐ Maior à D ☐ Maior à E

Conclusão postural

8. EXAME MOTOR

Trofismo e perimetria

Trofismo: ☐ Normotrofia ☐ Hipotrofia ☐ Hipertrofia Onde: _____

Segmento	Ponto de medida	Direito (cm)	Esquerdo (cm)
Braço	_____ cm acima do olécrano		
Antebraço	_____ cm abaixo do olécrano		
Coxa	_____ cm acima da base da patela		
Perna	_____ cm abaixo do ápice da patela		

Força muscular

Graus: 5 = normal • 4 a 1 = paresia (força reduzida) • 0 = plegia (sem força).

Membros superiores	D	E	Membros inferiores	D	E
Flexores de ombro			Flexores de quadril		
Abdutores de ombro			Abdutores de quadril		
Flexores de cotovelo			Extensores de joelho		
Extensores de cotovelo			Flexores de joelho		
Extensores de punho			Dorsiflexores		
Preensão palmar			Plantiflexores		

Manobras deficitárias

Olhos fechados, manter a posição de 30 s a 1 min e observar oscilação ou queda do membro.

Manobra	Resultado
Raimiste (MMSS)	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E
Mingazzini (MMSS)	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E
Mingazzini (MMII)	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E
Barré (MMII)	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E
Prova do pé (MMII)	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E
Queda em abdução (MMII)	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E

Tônus muscular

Tônus: ☐ Normotônico ☐ Hipotônico (flácido) ☐ Hipertônico

Se hipertônico: ☐ Espasticidade (sinal do canivete) ☐ Rigidez (roda denteada)

Músculo espástico: _____ **Lado:** _____ **Ashworth:** _____

Ashworth modificada: 0 normal • 1 / 1+ aumento leve • 2 em mais da metade do arco • 3 movimento difícil • 4 rígido.

9. COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO

Coordenação

Prova	Direito	Esquerdo
Índex-nariz	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada
Índex-índex	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada
Índex-nariz-índex	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada
Calcanhar-joelho	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada
Movimentos alternados rápidos	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada

Resultado: ☐ Diadococinesia (normal) ☐ Disdiadococinesia ☐ Adiadococinesia

Equilíbrio

Romberg (pés juntos, olhos fechados, 30 s): ☐ Negativo ☐ Positivo

Romberg sensibilizado (pés em tandem): ☐ Negativo ☐ Positivo

Equilíbrio de tronco (sentado): ☐ Preservado ☐ Alterado

Apoio unipodal – direito: _____ s **Esquerdo:** _____ s

Marcha: ☐ Normal ☐ Base alargada ☐ Sem dissociação de cinturas ☐ Com auxílio

Escala aplicada (Berg, TUG…): _____ **Resultado:** _____

10. SENSIBILIDADE

Paciente de olhos fechados, comparando os dois lados. Use: N = normal • Hipo = diminuída • Hiper = aumentada • A = ausente.

Sensibilidade	MSD	MSE	MID	MIE
Tátil (algodão)				
Dolorosa (objeto pontiagudo)				
Térmica (quente / frio)				
Posição (cinestesia)				
Vibratória (diapasão)				
Grafestesia				
Estereognosia				

Dermátomos / áreas alteradas: _____

11. DIAGNÓSTICO E PLANO DE TRATAMENTO

Principais problemas encontrados

Diagnóstico cinético-funcional *a disfunção do movimento, ex.: hemiplegia à esquerda*

Prognóstico: ☐ Favorável ☐ Reservado ☐ Desfavorável

Objetivos do tratamento

Prazo	Objetivo
Curto prazo	
Longo prazo	

Condutas *exercícios e recursos que serão usados*

Frequência: _____ x por semana **Duração da sessão:** _____ min

12. EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS

Data: ____/____/_____	**Atendimento nº _____**
Como o paciente chegou	
Sinais vitais	Início: PA ____/____ FC _____ FR _____ Fim: PA ____/____ FC _____ FR _____
Condutas realizadas	
Como o paciente saiu	

Data: ____/____/_____	**Atendimento nº _____**
Como o paciente chegou	
Sinais vitais	Início: PA ____/____ FC _____ FR _____ Fim: PA ____/____ FC _____ FR _____
Condutas realizadas	
Como o paciente saiu	

_____ **Acadêmico(a) avaliador(a)**

_____ **Supervisor(a)**